

SEMIOLOGIE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Dr M.S. DJEBAILI

Maitre assistant en médecine interne

Service de médecine interne EH DM

Laboratoire de recherche Diab-Suc;

Univeristé 3, Constantine.

02/10/2025

Introduction:



- La sémiologie: l'étude des signes mis en évidence par l'examen clinique du patient.



- L'examen clinique : plusieurs temps. débute toujours par un interrogatoire qui est une étape clef dans l'établissement de la relation patient-médecin.

- Au cours de l'interrogatoire, le patient décrit, guidé par le médecin, les symptômes qu'il ressent ou signes fonctionnels, dominés en pneumologie par l'essoufflement ou dyspnée, la toux associée parfois à une expectoration, et les douleurs thoraciques
- La description soigneuse des signes fonctionnels et des facteurs de risque respiratoire est importante car elle donne souvent les grandes orientations Dc.

Rappel physiologique de la respiration:

- Automatique, involontaire, et inconsciente.
 - a) inspiration: le temps actif, elle est possible grâce à la contraction du diaphragme (muscle insp) , s 'accompagne d 'une augmentation de volume de la cage thoracique rendant possible la pénétration de l 'air.
- Muscle accessoires :stérno-cléido-mastoïdien, scalènes, grand dorsal, grand pectoral: se contractent à l 'effort ou dans les gênes pathologique affectant l 'inspiration.

b) l'expiration: temps passif, grâce à l'élasticité pulmonaire la cage thoracique reprend sa position initiale ce qui rend possible la sortie de l'air.

- Le temps expiratoire est plus long que le temps inspiratoire.
- Les muscles expiratoires: petit et grand oblique, petit dentelé inférieur et transverse, mis en jeu dans les gênes pathologiques affectant l'expiration

LES SYMPTÔMES FONCTIONNELS DES MALADIES BRONCHO-PULMONAIRES

Parmi les signes fonctionnels qui orientent vers l'appareil respiratoire il y a :

↳ La dyspnée

↳ La toux

↳ L'expectoration

↳ L'hémoptysie

↳ La douleur

↳ Les sifflements

I. La dyspnée

1. Définition :

- c'est la difficulté ou gêne à respirer : la respiration devient consciente, volontaire, et pénible.
- motif de consultation majeur.

2. Analyse sémiologique de la dyspnée

La dyspnée doit être analysée par un interrogatoire soigneux comportant :

a/ Le mode de début :

- ☐ **Dyspnée aigue** : à début brutal, d'emblée à son maximum, en quelques heures à quelques jours.
- ☐ **Dyspnée chronique** : à début progressif, persistante depuis plusieurs S>8 à plusieurs mois.

b/ Les circonstances d'apparition :

Dyspnée d'effort :

- provoquée par un effort
- Obligeant le sujet à s'arrêter.
- Il faut faire préciser le type d'effort qui la fait apparaître (sévérité de la dyspnée) :

+++

nombre d'étages montés, nombre de marches parcouru ou des gestes quotidiens pouvant la déclencher: s'habiller, faire sa toilette...etc

Dyspnée de décubitus :

- Orthopnée.
- Difficulté ou gêne respiratoire survenant au repos, en position allongée sur le dos et qui s'améliore en position assise ou debout
- Elle est décelée surtout dans l'insuffisance cardiaque gauche, dont elle est caractéristique.

c/ Le mode d'évolution :

- ❑ **Dyspnée paroxystique** : crises de dyspnée
 - durant de quelques minutes à quelques heures
 - séparées par des intervalles de respiration normale ; exemple : la crise d'asthme.

- ❑ **Dyspnée permanente** : ou dyspnée de repos,
 - apparaît au terme d'une période plus ou moins longue de dyspnée d'effort,
 - se définit par un essoufflement en décubitus dorsal strict, amélioré par la position assise : c'est *l'orthopnée*.

d/ Selon la fréquence respiratoire :

- ❑ **Polypnée** : lorsque la fréquence respiratoire augmente et devient supérieure à 22 mouvements/minute chez l'adulte et à 30 mouvements/minute chez l'enfant.
- ❑ **Bradypnée** : lorsque la fréquence respiratoire diminue respectivement au dessous de 14 chez l'adulte et 22 chez l'enfant.

e/ Selon le temps respiratoire :

- ❑ **Bradypnée inspiratoire** : se voit lorsqu'il y'a un obstacle à la pénétration de l'air : obstruction laryngée par une inflammation du larynx (laryngite), par des fausses membranes (diphthérie laryngée) ou par un corps étranger.
- ❑ **Bradypnée expiratoire** : se voit lorsqu'il y'a un obstacle à la sortie de l'air par atteinte des bronches de tous calibres, ce qui est réalisé dans la crise d'asthme.

3. Les fausses dyspnées :

Ce sont des dyspnées sans substratum anatomique, ne s'accompagnent pas de gêne respiratoire.

► La respiration de Kusmaul :

c'est une hyperventilation réalisant une respiration régulière et profonde, égale aux deux temps qui sont séparés par une pause (respiration en créneau). Elle s'observe dans les états d'acidose métabolique.

► La respiration périodique de cheyne-stokes :

elle est le témoin d'un désordre nerveux central. C'est une irrégularité du rythme respiratoire qui se caractérise par des cycles respiratoires d'amplitude croissante devenant bruyants, puis d'amplitude décroissante aboutissant à une pause complète de quelques secondes (apnée).

► La respiration périodique du syndrome de pickwick :

c'est également une irrégularité du rythme respiratoire, elle se voit chez certains obèses, elle est alors associée à une somnolence diurne. Cette respiration périodique s'observe la nuit, elle est faite de la succession de cycles caractérisés par une inspiration lente profonde, suivie de mouvement respiratoires courts et rapides et d'une apnée expiratoire complète.

II. La toux

1. Définition:

La toux est une brusque, bruyante et brève expulsion d'air par les bronches et la trachée .

- La toux peut être volontaire,
 - le plus souvent elle est involontaire.
- c'est un réflexe de défense destiné :

➡ à empêcher la pénétration de corps étrangers dans les voies respiratoires,

➡ à expulser les mucosités qui s'y trouvent accumulées (exemple : hypersécrétion bronchique).

2. Les différents types de toux :

a / selon le degré de sécheresse ou d'humidité :

➡ La toux sèche

➡ La toux humide ou grasse

- ❑ **La toux sèche** : bruit sonore plus ou moins éclatant : elle est soit brève, soit quinteuse (plusieurs secousses de toux), elle n'est pas suivie d'expectoration.
- ❑ **La toux humide ou grasse** : c'est une toux dite productive, elle peut être accompagnée d'une expectoration.

b / Selon le mode de debut :

- ❑ **La toux aigue** : récente, dure quelques heures à quelques semaine (3-4 semaine).

lié souvent à une pathologie infectieuse bronchique ou des voies aériennes supérieurs

- ❑ **La toux chronique** : dure plus de 1 mois, se voit dans les bronchite chronique ou asthme.

c / Selon le rythme de la toux :

- ❑ **La toux moniliforme** : 1 à 2 secousses de toux irrégulièrement espacés de temps à autre.
- ❑ **La toux quinteuse ou spasmodique** : survient par accès ou quintes constituées par une série de secousses expiratoires entrecoupées d'une inspiration profonde.

d / La toux émétisante :

↳ est une toux responsable de vomissement.

III. L'EXPECTORATION

1. Définition :

Rejet au cours d'efforts de toux de sécrétions anormales présentes dans l'arbre trachéo-bronchique.

Elle est toujours pathologique.

- ✓ C'est le **satellite de la toux** sauf chez les femmes et les enfants au dessous de 12 ans qui toussent sans cracher.

► L'expectoration pathologique est la conséquence :

- ☛ soit de **l'augmentation d'une des composantes normales**
ex : expectoration muqueuse de la crise d'asthme ou
: expectoration séreuse au cours de l'œdème aigu
du poumon,
- ☛ soit **d'une suppuration bronchique ou pulmonaire.**

2. La valeur sémiologique de l'expectoration est fondamentale

⇒ d'où l'importance de la recueillir dans un verre gradué. On notera :

- ✓ l'abondance,
- ✓ la couleur,
- ✓ l'odeur,
- ✓ la transparence,
- ✓ la consistance,
- ✓ l'aération
- ✓ l'horaire.

3. Les différents types d'expectorations

① L'expectoration muqueuse :

est formée de mucus.

Les crachats sont :

- transparents,
- visqueux,
- aérés.

- ✓ Cette expectoration traduit l'hypersécrétion de mucus bronchique non accompagnée d'infection. (fin de la crise d'asthme).

② L'expectoration purulente :

faite de **pus franc** qui provient d'un foyer de suppuration pulmonaire (abcès du poumon), elle est inodore ou putride (abcès à anaérobies).

③ L'expectoration mucopurulente: fréquente

c'est une expectoration **muqueuse** mêlée d'îlots de **pus** jaune verdâtre.

suivant son abondance on distingue :

- l'expectoration mucopurulente de petite abondance,
- l'expectoration mucopurulente de grande abondance : 150 à 200 cm³ par 24/h;
 - ☛ c'est la **bronchorrhée**.

Elle est caractéristique de la dilatation des bronches et de la bronchite chronique.

④ L'expectoration séreuse :

c'est une expectoration liquide, très fluide, homogène (OAP).

⑤ L'expectoration hémoptoïque :

c'est une hémoptysie de petite abondance.

IV. LA VOMIQUE

1. Définition

C'est le **rejet** par la bouche d'une **collection purulente** ayant pénétré par effraction dans les voies respiratoires.

- ✓ La vomique est d'installation brutale ce qui la distingue de l'expectoration qui apparaît progressivement.

a/ Suivant la qualité du liquide rejeté

- ❑ La vomique purulente : c'est le rejet de pus.
- ❑ La vomique eau de roche : c'est le rejet d'un liquide clair, eau de roche, se voit lors de *rupture d'un kyste hydatique interparenchymateux* dans les bronches

b/ Suivant la quantité de liquide rejeté

- ❑ La vomique massive
- ❑ La vomique fractionnée : c'est le rejet de liquide le plus souvent de pus par petites quantités mais de manière répétée.
- ❑ La vomique nummulaire ou masquée : elle est réduite à de simple crachats purulents répétés et rapprochés.

V. L'HEMOPTYSIE

1. Définition

C'est le **rejet par la bouche**, dans un **effort de toux** de sang provenant des voies aériennes sous glottiques.

2. Les différents types d'hémoptysie.

Suivant l'abondance on distingue :

a / L'hémoptysie de grande abondance
(plus de 300cc) :

elle est rare. Elle survient **brutalement** sans avertissement, une brusque quinte de toux est suivie du rejet d'une grande quantité de sang qui coule à flots.

b / L'hémoptysie de moyenne abondance

c'est la plus fréquente.

Elle est précédée de signes annonciateurs ou **prodromes** (sensation de chaleur rétrosternale, saveur métallique dans la bouche, angoisse), puis l'hémoptysie survient accompagnée de dyspnée.

c / L'hémoptysie de petite abondance :

- ✓ elle peut revêtir plusieurs aspects :
 - ☞ Crachats sanglants, isolés, expectorés en petit nombre entre expectorations mucopurulentes.
 - ☞ Parfois un seul crachat homogène, rouge entièrement teinté de sang.
- ✓ a la même valeur sémiologique que les hémoptysies de grande abondance.

Deux aspects particuliers peuvent être rencontrés :

⇒ **le crachat hémoptoïque de Laennec** :
expectoration faite de crachats muco
sanglants, noirâtres, s'observe 24 à 36 h
après une embolie pulmonaire, lorsqu'il y a
constitution d'un infarctus pulmonaire.

⇒ **le crachat rouillé** :
expectoration faite de crachat visqueux de
couleur orangée apparaissant au troisième
jour de la pneumonie franche lobaire aigue.

3. Le diagnostic différentiel

Il repose sur un interrogatoire **minutieux** qui permettra d'éliminer ce qui n'est pas une hémoptysie :

👉 **Hémorragie d'origine buccale ou pharyngée** s'évacue par simple expulsion sans qu'il y ait toux.

✌ **L'épistaxis postérieure** : où le sang coulant sur le larynx peut provoquer un réflexe de toux, il existe en général une épistaxis antérieure associée.

 **L'hématémèse** : est précédée de troubles digestifs, nausées et s'accompagne d'effort de vomissements, le sang rejeté contient des débris alimentaires.

4. Les étiologies de l'hémoptysie :

- o - Tuberculose pulmonaire (la plus fréquente)
- o - Rétrécissement mitral
- o - Cancer bronchique
- o - Dilatation des bronches

VI. LES DOULEURS THORACIQUES

Elles s'observent au cours des affections :

- *de la plèvre pariétale,*
- *du parenchyme pulmonaire juxta-corticale*
- *de la paroi thoracique et du*
- *du médiastin*

1. Analyse sémiologique de la douleur

Elle repose sur l'interrogatoire qui précisera :

- La topographie de la douleur,
 - Le siège superficiel ou profond et les irradiations,
 - Le mode de début brutal ou progressif,
 - Les signes accompagnateurs en particulier la dyspnée.

A / Les douleurs thoraciques ayant pour origine l'appareil respiratoire :

ce sont des douleurs profondes qui ont en commun 2 caractères :

- ⇒ Elles sont **aggravées** par l'**inspiration profonde** , la **toux** et les **changements de position**
- ⇒ Elles **réalisent** une douleur unilatérale à type « **de point de côté** »

❑ Douleur d'origine pleurale :

siège à la base du thorax

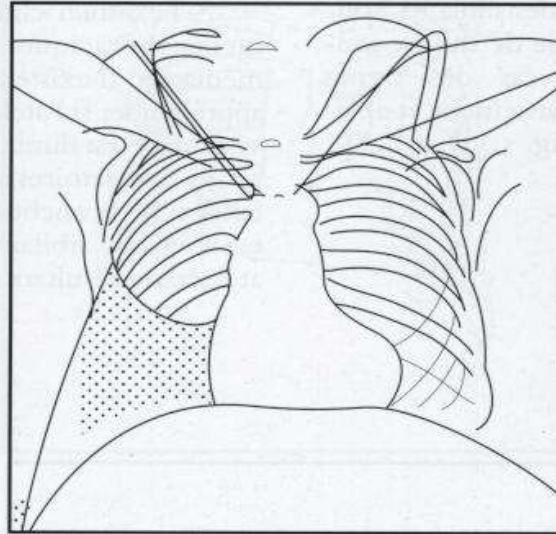
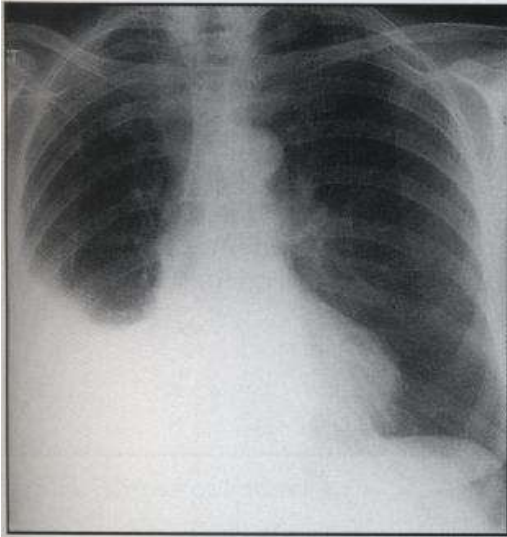
↳ Épanchement pleural aérien (pneumothorax):

irruption brutale de l'air dans l'espace pleural après rupture de la plèvre viscérale avec collapsus pulmonaire.

Accident aigue entraînant une douleur déchirante avec angoisse, dyspnée et parfois perte de connaissance.

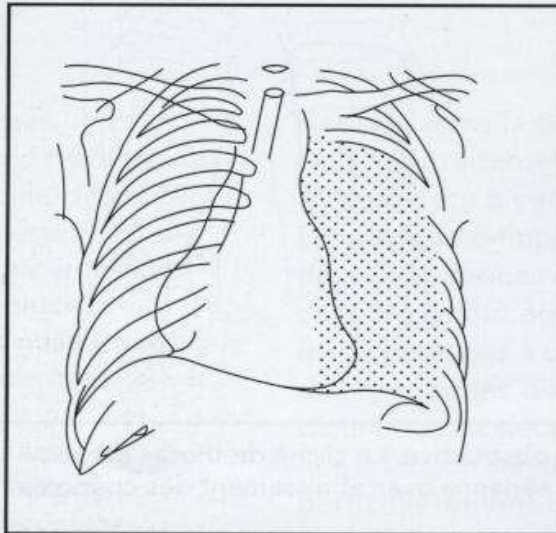
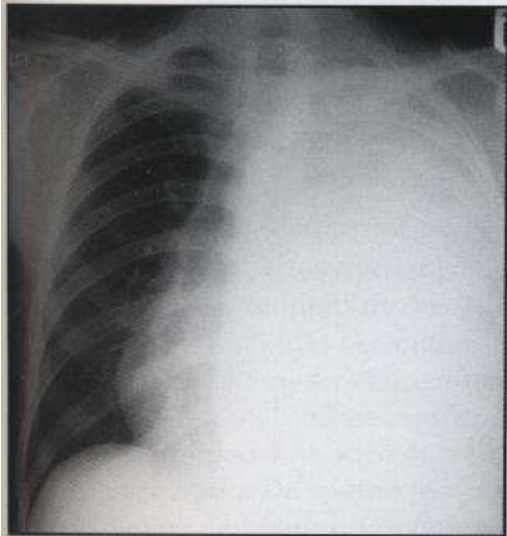
↳ Épanchement pleural liquidien (pleurésie)

- Liquide inflammatoire ou exsudat (pleurésie séro-fibrineuse; PSF):
douleur modérée à début progressif
+ fébricule
- Liquide purulent (pleurésie purulente):
douleur variable
+ fièvre élevée et AEG
- Épanchement sanglant (hémothorax):
début brutal souvent post-traumatique



Médiastin en place
Ampliationn thoracique
normale
Matité
Diminution du murmure
vésiculaire
Souffle pleurétique au sommet
de l'épanchement

Fig. 5.50 Épanchement pleural de faible abondance.



Médiastin déplacé
Diminution de l'ampliation
thoracique
Matité
Abolition du murmure
vésiculaire

Fig. 5.51 Épanchement pleural abondant avec déplacement médiastinal.

❑ Douleur d'origine parenchymateuse :
essentiellement dans

↳ la pneumonie franche lobaire aiguë (PFLA)
douleur vive , brutale de siège sous-
mamelonnaire et qui s'accompagne de fièvre
élevée, toux, expectoration (crachats
rouillés).

❑ Douleur de l'embolie pulmonaire:
migration d'un caillot dans une artère
pulmonaire qui peut être suivie -
inconstamment- d'un infarctus pulmonaire.
La douleur est vive brutale basithoracique,
ou parasternale avec irradiation en demi-
ceinture.

B/ Les douleurs thoraciques d'origine pariétale:

Ce sont des douleurs superficielles

- ❑ Douleur thoracique post-traumatique
- ❑ Névralgie intercostale
- ❑ Névralgie phrénique: douleur thoracique basse, irradiant le long du bord externe du sternum vers l'épaule.
- ❑ Zona : maladie virale qui se manifeste par une éruption érythémato-vésiculeuse de trajet radiculaire. La douleur est à type de cuisson.
- ❑ Syndrome de Tietze: douleur localisée au niveau d'une articulation chondro-sternale ou chondro-costale

VII. LES SIFFLEMENTS

□ Les sibilants:

son aigu, ils sont plus perceptibles en expiration. Ils impliquent un rétrécissement des voies aériennes (asthme et bronchopathie chronique obstructive)

□ Le stridor:

bruit rude inspiratoire, conséquence d'un obstacle sur les voies aériennes hautes

Merci